

HISTORIA CLÍNICA EN URGENCIAS

José Rebollar Andrés, Julio Tito Camino Acha.

La historia clínica es un documento médico legal que debe de contener los siguientes apartados.

Apartados de la historia clínica de urgencias hospitalarias.

1. Datos de filiación del centro asistencial: Nombre del hospital, dirección, teléfono, departamento/servicio.

2. Datos de filiación del paciente: nombre y apellidos, dirección, fecha de nacimiento, edad, DNI, sexo, teléfono, número de historia clínica, fecha y hora de ingreso, fecha y hora de alta hospitalaria e inicio de visita médica, hora de triaje.

3. Anamnesis. Es una relación de datos solicitados al paciente, familiares o personas que presenciaron el suceso o cuadro clínico, que nos lleve a una aproximación diagnóstica, nos orienta en la exploración, pruebas diagnósticas e inicio de tratamiento. Nos interesa saber cuándo y cómo se inició el cuadro clínico, qué circunstancias le rodearon o desencadenaron, con qué tipo de clínica cursó, duración, cómo ha evolucionado en el tiempo, si se ha tomado algún tratamiento y su respuesta, si lo ha presentado en otras ocasiones y con qué diagnóstico y tratamiento.

3.1. Motivo de consulta: hace referencia al síntoma o signo por el que solicita asistencia el paciente: fatiga, astenia, anorexia, dolor, pérdida de peso, mareo, hinchazón de piernas, coluria, tumoración, deformidad, etc.

3.2. Antecedentes patológicos.

- **a. Antecedentes familiares.** Preguntar por enfermedades neoplásicas, metabólicas y cardiovasculares de los padres, hermanos. IAM. DM. HTA, neo de colon, etc.
- **b. Antecedentes personales.**
- **Alergias medicamentosas:** SI / NO. Si las tiene apuntarlas todas, si no recuerda dejar constancia por escrito: No recuerda la medicación que le produce alergias.
- **Hábitos tóxicos:** Alcohol, tabaco, drogas.
- **Medicación habitual o crónica:** que medicación toma cada día? amlodipino, atorvastatina, sintrom, etc.
- **Vacunación:** si tiene vacunas completas de tétanos, hepatitis, etc.
- **Enfermedades crónicas:** Tiene alguna enfermedad? Ejm. HTA. DM II. dislipemia. EPOC. Y situación basal del paciente de tercera edad, tipo vida, dependiente o no para las ABVD. Etc.
- **FUR:** en mujeres jóvenes, métodos anticonceptivos, dejar escrito si tiene posibilidad de embarazo o no, etc.
- **Intervenciones quirúrgicas:** Tiene alguna operación, lo han operado de algo?. Apendicectomizado, amigdalectomizado, etc...

3.3. Enfermedad actual o historia de la enfermedad. Se recomienda dejar claro lo que refiere el paciente; iniciar con la frase: "según refiere el paciente" hace 7 días viene presentando dolor abdominal, tipo cólico, no irradiado, que dura 5 minutos que cede con analgesia básica: paracetamol o Ibuprofeno o metamizol, etc. o cede con ingesta de alimentos, similar clínica ya presente en otras ocasiones, no náuseas, no vómitos, no alteración del hábito intestinal. No síndrome general, afebril, etc.

4. Examen físico. Se tomarán las constantes vitales: Tª, TA, FC, FR, SatO2, glucemia. Debe ir

encaminada al cuadro clínico que se nos ha descrito en la anamnesis y confirmarnos la sospecha diagnóstica que tenemos. No obviar que otros aparatos y sistemas también pueden estar implicados o afectados. Debe seguir un orden craneocaudal o viceversa, desde el punto de vista anatómico, funcional y por aparatos y sistemas. Además de una valoración general del paciente.

4.1. Valoración general subjetiva: buen, regular o mal estado general, coloración (normocoloreado, icterico, pálido), hidratación (normohidratado, deshidratado), perfusión, nutrición, nivel de conciencia (orientación, desorientado), colaboración en la realización de la HC, frecuencia respiratoria (eupneico, disneico, taquipneico), sensación térmica y si está o no sintomático.

4.2. Cabeza y cuello: cambios inflamatorios (mastoideos, faciales, cervicales, etc.), masas, megalias, ingurgitación yugular, soplos carotídeos, etc.

4.3. Cardíaca: ritmicidad (rítmicos, arrítmicos), frecuencia aproximada, tonos, soplos y roces.

4.4. Pulmonar: Presencia o no de roncus, sibilantes, crepitantes, ventilación pulmonar general y asimetría en la auscultación, FR. Por inspección veremos si hay tiraje, defectos anatómicos del tórax, asimetría entre hemitórax en los movimientos y tipo de respiración.

4.5. Abdomen. **1. Por inspección:** cicatrices, hernias, circulación lateral y forma. **2. Por auscultación:** ruidos intestinales y soplos. **3. Por palpación:** masas, megalias, hernias, puntos dolorosos, defensa, ascitis, etc. **4. Por percusión:** buscaremos matidez, timpanismo, oleada ascítica, dolor renal. Etc.

Tacto rectal: si sangrado rectal, sospecha de neo local o sangrado, etc.

4.6. Extremidades: asimetría de pulsos periféricos, perfusión, signos de TVP o flebitis, varices, edemas, puntos dolorosos, estabilidad articular, limitación funcional, derrames articulares, sensibilidad, etc.

4.7. Neurológica: nivel de conciencia, orientación témporo-espacial y en persona, alteraciones pupilares, alteraciones de la motilidad ocular, hemianopsias, pares craneales, pérdida de la fuerza, tono muscular o sensibilidad, alteraciones de los ROT y plantares, dismetrías, alteraciones de la estática y marcha, y signos meníngeos.

4.8. ORL: cambios inflamatorios óticos, nasales u orofaríngeos, líquidos patológicos (sangre, pus, líquido cefalorraquídeo, etc).

4.9. Locomotor: buscar puntos dolorosos, deformidades, cambios inflamatorios, limitación funcional, derrames e inestabilidad. En los traumatismos exploración neurológica y vascular distal.

5. Pruebas complementarias. Las pruebas complementarias dependerán de la clínica que presente el paciente. La anamnesis y la exploración debe coincidir en la sospecha diagnóstica y las pruebas a solicitar irán encaminadas a confirmar y en su defecto a descartar el diagnóstico. La petición de pruebas improcedentes demora la asistencia y la calidad asistencial.

6. Evolución. Debemos de realizar una pequeña evolución. Paciente tras administración de medicación y/o sueroterapia presenta franca mejoría y/o estabilidad clínica. Se deja indicaciones de signos de alarma.

7. Interconsultas. Indicar la especialidad interconsultada. Dejar siempre por escrito la interconsulta realizada, recordar la HCL es un documento médico-legal. No escribir en la HCL comentarios subjetivos que pueden ser mal interpretados por el paciente/familiares y den paso a reclamaciones de carácter legales.

8. Tratamiento en urgencias. Todo tratamiento será congruente con el diagnóstico, indicar siempre: nombre del fármaco, dosis, vía de administración.

7. Impresión diagnóstica. Nuestro diagnóstico, tiene que tener congruencia y concordancia con el tratamiento indicado al momento del alta y con la clínica del paciente motivo por el cual acude a

urgencias.

8. Tratamiento al alta. Según el diagnóstico el paciente recibirá el tratamiento específico, debiendo ser claro, preciso, indicar siempre: el fármaco, la dosis, la vía y tiempo de toma de la medicación.

9. Plan al alta. Debemos de procurar escribir algunas recomendaciones generales.

- Se recomienda control por su Médico de cabecera.
- Se recomienda seguimiento y control por digestivo de cupo (o la especialidad que corresponda) según tramite de su Médico de cabecera con carácter: normal, preferente, si ponemos urgente se debe de ingresar al paciente, no se debería altar al paciente.
- Si signos de alarma: Fiebre, aumento del dolor, náuseas o vómitos, acuda a su centro de salud o al área de urgencias hospitalarias más próximo.

10. Datos del médico y firma. La historia debe de estar firmada por el médico y deberá de figurar el nombre, apellido y número de colegiado de los profesionales que atendieron al paciente. Adjunto 1, será el responsable, adjunto 2 será otro profesional que participó en su asistencia médica del paciente.

Normativa de La historia clínica está regulada en España por.

- Ley General de Sanidad. Del 14/1986, de 25 de abril, BOE núm. 102, de 29 de abril de 1986.
- Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre: LOPD: Protección de Datos de Carácter Personal.
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, BOE núm. 274, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

BIBLIOGRAFÍA.

- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 15 de mayo de 2002, núm. 274. Referencia: BOE-A-2002-22188.
- Vázquez Lima M.J, Casal Codesido J.R. Guía de Actuación en Urgencias. 5ª edición. Ed. Panamericana, S.A; 2018. P. 3-6.